

CRISIS DE ANSIEDAD - ATAQUE DE PÁNICO

V. Ámez Cepeda, R. Gómez Martínez, C.M. Franch Pato.

INTRODUCCIÓN

Ansiedad normal: La ansiedad nos pone en alerta y nos ayuda a afrontar amenazas, es normal experimentar ansiedad, a menudo se acompaña de una sensación desagradable y vaga, un malestar que puede estar acompañado de síntomas vegetativos (en mayor o menor grado) y de inquietud. Esto es adaptativo cuando nos ayuda a afrontar situaciones.

Ansiedad patológica: Cuando la ansiedad deja de ser útil para transformarse en un impedimento para llevar a cabo la vida cotidiana.

Ansiedad y urgencias: No podemos banalizar la ansiedad ya sea por su alta prevalencia en el servicio de urgencias y por la incapacidad que provoca, como por la trascendencia de enfermedades somáticas que pueden subyacer a un cuadro de ansiedad.

Según las tasas de prevalencia en la población general, hasta el 11,8% presentan algún trastorno de ansiedad en un año y otro 11% refieren manifestaciones de ansiedad asociadas a enfermedades físicas.

Actitud:

- Descartar patología orgánica que justifique el cuadro de ansiedad.
- Pautar tratamiento adecuado y derivar al especialista correspondiente.

DIAGNÓSTICO

Signos y síntomas de ansiedad:

Síntomas y signos físicos	Síntomas psíquicos	
• Temblores • Sudoración • Rubor, palidez • Taquicardia • Palpitaciones • Sensación disneica • Hiperventilación forzada • Dolor precordial	• Malestar abdominal, náuseas, diarrea • Vértigo, mareo, desvanecimiento • Parestesias • Midriasis • HTA • Hiperreflexia • Dificultad para tragar	• Sensación de desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (estar separado de uno mismo) • Sensación de muerte inminente • Sensación de inestabilidad • Miedo a perder el control, a volverse loco

Diagnóstico diferencial

- Miedo o angustia como reacción psíquica a cualquier malestar físico o tratamiento doloroso.
- Trastornos orgánicos:

Enfermedades cardiovasculares	Enfermedades Neurológicas
-------------------------------	---------------------------

Enfermedades cardiovasculares	Enfermedades Neurológicas
Anemia Angina, IAM ICC HTA Hiperreactividad beta-adrenérgica Prolapso válvula mitral Taquicardia auricular paradójica	Neoplasias intracraneales TCE Síndrome posconfusional Hemorragia subaracnoidea Encefalitis Epilepsia Enfermedad cerebrovascular Migraña Esclerosis múltiple Corea de Huntington Enfermedad de Wilson
Enfermedades Pulmonares	
Asma Hiperventilación TEP	
Enfermedades endocrinas	Otras enfermedades
Hipo/ hipertiroidismo Hipo/ hiperglucemia Hipoparatiroidismo Síndrome carcinoide Enfermedad de Addison Síndrome de Cushing Feocromocitoma Trastorno menopáusico Síndrome premenstrual	Trastornos electrolíticos Infecciones sistémicas Uremia Déficit de vitamina B12 Hipoxia Intoxicación por metales pesados Lupus eritematoso sistémico Artritis reumatoide Arteritis de la temporal Poliarteritis nodosa

- Abuso de drogas o abstinencia:

Intoxicación por fármacos y sustancias	Abstinencia de fármacos y sustancias		
Anfetaminas Alucinógenos Cocaína Marihuana	Nicotina Anticolinérgicos Teofilina	Alcohol Opiáceos Cafeína	Hipnótico- sedantes Antihipertensivos

- Comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos.

Pruebas complementarias

En ocasiones es conveniente para realizar el diagnóstico diferencial:

Analítica sanguínea: hemograma con formula leucocitaria, bioquímica básica, coagulación, sistemático y sedimento de orina, tóxicos en orina, ECG, Rx tórax.

TRATAMIENTO

- Tranquilizar al paciente:
 - Indicarle que las pruebas complementarias han sido normales.
 - No decirle que no le pasa nada porque sí le pasa.
 - Explicarle lo que le está ocurriendo y la interpretación errónea que está realizando de sus síntomas neurovegetativos.
- Si hay hiperventilación: se le propone respirar dentro de una bolsa de plástico para evitar una crisis de tetania.
- Psicofármacos:** El tratamiento de elección son Benzodiacepinas por vía oral. Es conveniente

usar Bzd de acción rápida y vida media corta: Lorazepam, alprazolam, diazepam, clonazepam.

La vía de administración será oral o sublingual.

Evitar la vía intramuscular porque su absorción es errática.

- Lorazepam: 1 mg (1-5 mg). Dosis máxima diaria: 7.5 mg.
- Diazepam: 10 mg (5-20 mg). Dosis máxima diaria: 30 mg.
- Alprazolam: 0.5 mg (0.5-2 mg). Dosis máxima diaria: 6 mg
- Clonazepam: 0.5 mg (0.5-2mg). Dosis máxima diaria: 6 mg.

Se puede repetir a los 30 min si no se ha resuelto la crisis.

Trastorno de ansiedad /trastorno de pánico

En caso de crisis de ansiedad/ ataques de pánico de repetición, podemos hablar de un trastorno de pánico: los ataques son imprevistos y recurrentes, producen preocupación continua y el paciente tiene dificultades para mantener su vida habitual. En este caso estaría indicado pautar un tratamiento a largo plazo:

Los fármacos de primera elección son los ISRS (citalopram, escitalopram, paroxetina, fluoxetina, sertralina y fluvoxamina) siendo conveniente asociar una BZD durante 2-3 semanas y retirarla progresivamente.

ALERTA

- Cuidado con prolongar un tratamiento con BZD ya que producen habituación y tolerancia y es complicada su retirada.

Derivación:

- MAP
- Psiquiatra CSM:
 - Pacientes con síntomas resistentes pese al tratamiento.
 - Presencia de agorafobia o de otros trastornos fóbicos.
 - Sospecha de trastorno obsesivo-compulsivo.
 - Presencia de otros trastornos psiquiátricos comórbidos (depresión, abuso de tóxicos)
 - Ausencia de respuesta al tratamiento farmacológico.

BIBLIOGRAFÍA

- Chinchilla A. Manual de urgencias psiquiátricas. Barcelona: Masson, 2010. P. 393-408.
- Kaplan HI. Trastornos de ansiedad. Sinopsis de Psiquiatría. 8ª ed. Madrid: médica Panamericana, 1999; p. 657-710